

권 고

제 목 단가계약 운영에 관한 사항

소 관 기 관 본사 □.□.□.□.실, i · ii · iii · iv · ■ ■ · v ㉠㉠병원

조 치 기 관 본사 □.□.□.□.실, 중앙 · ii · iii · iv · ■ ■ · v ㉠㉠병원

내 용

1. 업무개요

본사 및 6개 ㉠㉠병원은 진료재료 및 의약품 등 구매계약을 체결하면서 계약의 목적과 특성에 적합한 계약 방식을 적용하고, 관련 법령에서 정한 절차를 준수하여 계약을 체결하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

계약은 계약금액의 확정 여부에 따라 확정계약, 개산계약 및 사후원가검토 조건부계약으로 구분되며, 이 중 확정계약은 계약 체결 시 계약금액을 확정하는 통상적인 계약 방식으로 대부분의 공공계약에 적용되고 있다.

국가계약법령에서는 ‘확정계약’이라는 용어를 별도로 사용하고 있지 않으나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따르면, 계약의 목적 · 계약금액 · 이행기간 · 계약보증금 등을 명시한 계약서에 담당 공무원과 계약상대자가 기명 · 날인 또는 서명함으로써 계약이 확정된다고 규정하고 있어 확정계약을 원칙으로 하고 있다.¹⁾

1) 감사원, 「공공계약 실무가이드」 (2024년 개정판), p.64, (1) 확정계약 참고

또한, 확정계약은 계약 체결 시 정한 계약금액을 기준으로 대가를 지급하는 방식으로, 별도의 사후정산 조건이 없는 한 실제 소요 비용이 계약금액과 다르다는 사유만으로 계약금액을 변경하여 지급할 수 없다.

아울러, 계약금액의 결정 방식에 따라서는 총액계약과 단가계약으로 구분되며, 총액계약은 계약목적물 전체에 대하여 총액으로 계약을 체결하는 방식이고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제50조(계약보증금) 제1항에 따라 계약금액의 10% 이상을 계약보증금으로 납부하도록 정하고 있다.

반면, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조(단가계약)에 따르면, 일정 기간 계속하여 제조·수리·가공·매매·공급·사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때는 해당 연도 예산의 범위에서 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있으며, 이는 물량 변동이 예상되는 계약에 대하여 단가를 기준으로 계약을 체결함으로써 수량 변동에 따른 위험을 합리적으로 조정하기 위한 취지이다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제7조(추정가격의 산정)에 따르면, 단가계약의 경우 추정단가에 조달예정수량을 곱한 금액으로 추정가격을 산정하고, 같은 시행령 제50조(계약보증금)에서는 단가계약의 경우 매회별 이행예정량 중 최대량에 계약단가를 곱한 금액의 10% 이상을 계약보증금으로 납부하도록 규정하고 있다.

따라서, 계약담당자는 계약의 목적과 특성, 물량 변동 여부 등을 종합적으로 고려하여 계약 방식을 적정하게 결정하여야 하며, 단가계약을 체결하는 경우 계약금액의 산정, 계약보증금의 징수 및 계약상대자의 권리 등이 계약의 실질에 부합하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 본사 및 6개 ㉠㉠병원의 진료재료·약품 등 구매계약을 검토한 결과, 계약명이 ‘단가계약’으로 되어 있거나 계약의 실질이 단가계약에 해당함에도 예정수량을 기준으로 총 계약금액을 확정하는 총액계약 형태로 계약이 체결되었다.

또한, 특수조건에는 “본 계약의 수량은 예정량으로 납품수량은 증감될 수 있다”고 명시되어 있어 실제 납품수량 변동을 전제로 계약이 운영되고 있었으나 총액계약은 원칙상 계약 체결 시 계약금액이 확정되므로, 예정수량과 실제 납품수량 간 차이가 발생할 경우 계약금액 정산 기준 및 납품 의무 범위에 대한 분쟁 소지가 존재하는 것으로 보인다.

아울러, 계약보증금 또한 단가계약 기준이 아닌 총액계약 기준인 “총 계약금액의 5%(국가계약법 한시적 특례 적용) 또는 10% 이상”을 납부하고 있어 단가계약의 법적 기준보다 높은 수준의 계약보증금을 부담하고 있었다.

이와 같이 계약의 실질과 계약 형식이 일치하지 않아 계약금액 산정, 계약 보증금 징수 및 계약상대자의 권리·의무가 불명확해질 우려가 있으므로 계약의 실질에 부합하는 방식을 적용할 수 있도록 계약 방식을 개선할 필요가 있다.

[표] 본사 및 6개 ㉠㉠병원 단가계약 체결 현황(대표계약 2건)

구분	계약명	계약형태	비고

* 데이터 출처 : 병원별 연간 단가계약·진료재료 계약서(EP 시스템)

관계기관 의견

본사 □.□.□.□.실에서는 의약품 중앙구매 계약(연간 약 *,***억 원 규모)의 경우, 계약 방식을 단기간 내 총액계약에서 단가계약으로 전환할 경우 입찰 참여업체의 가격 산정 혼선, 유찰 가능성 증가 등 예상하지 못한 문제가 발생할 수 있으며, 의약품 계약은 병원 진료 운영과 직접 연계되는 필수 계약으로 공급 차질 발생 시 진료에 영향을 미칠 우려가 있다는 의견을 제시하였다.

이에 따라 의약품 중앙구매 계약은 공급 안정성, 입찰 경쟁성 및 계약 운영상 영향 등을 종합적으로 검토한 후 중장기적인 검토를 거쳐 단계적으로 전환하는 것이 타당하며, 다만 진료재료 구매계약은 단가계약으로 전환이 가능하다는 의견을 제시하였다. 그 외 중앙 · ii · iii · iv · ■■■ · v ㉔㉔병원에서는 감사결과를 수용하여 별다른 의견을 제시하지 않았다.

관계기관 의견을 검토한 결과, 본사 주관의 의약품 중앙구매 계약은 연간 약 *,***억 원 규모의 대형 계약이며 환자 진료와 직결되는 필수 계약인 점을 고려할 때, 계약 방식의 급격한 변경은 입찰 경쟁 및 공급 안정성에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 단계적으로 단가계약을 도입할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항 ↔↔이사 및 중앙 · ii · iii · iv · ■■■ · v ㉔㉔병원장은

향후 계약 체결 시에는 계약의 실질에 부합하는 계약 방식 및 계약보증금 산정 기준을 적용하고, 본사 의약품 중앙구매 계약은 계약 규모, 입찰환경 등을 종합적으로 고려하여 단가계약 적용을 단계적으로 추진하시기 바랍니다. (권고)